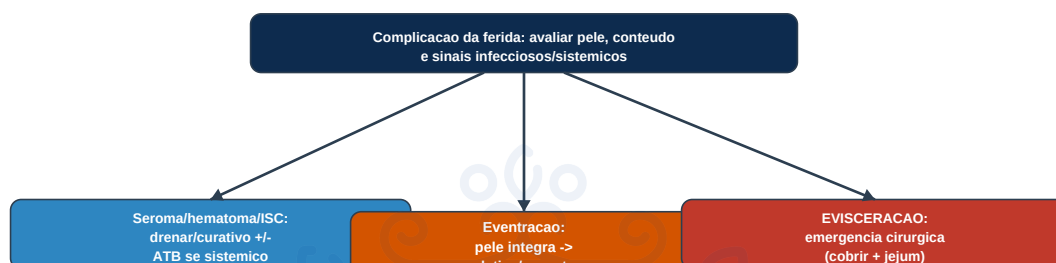


FERIDA OPERATÓRIA — SEROMA À EVISCERAÇÃO

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

FERIDA OPERATÓRIA — DA COLEÇÃO À EVISCERAÇÃO



COMPLICAÇÕES DA FERIDA — TIPOS

Complicação	Conduta
Seroma	Líquido seroso; pequeno -> observar; volumoso/sintomático -> aspiração (pode repetir); compressão previne
Hematoma	Acúmulo de sangue; pequenos reabsorvem; drenar se grande/expansivo/infectado
Deiscência	Abertura das camadas; pele -> limpeza + curativo; profunda sem aponeurose -> avaliar nova sutura/revisão
Infecção de sítio cirúrgico (ISC)	Eritema, calor, pus, dor, febre; abrir pontos + drenar + lavar; ATB se celulite/sistêmico/profundo/cavitário

INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO (ISC) POR PROFUNDIDADE

TRÊS NÍVEIS

- Superficial (pele/subcutâneo): abrir alguns pontos, drenar coleção/abscesso, irrigar; ATB só se celulite ou sinais sistêmicos
- Profunda (fáscia/músculo): abrir pontos, drenar, lavar, avaliar desbridamento e PRESCREVER ATB
- Órgão/cavidade: abrir pontos, ATB, drenagem externa, considerar reabordagem para limpeza da cavidade
- Investigação adicional: hemograma, PCR, US de partes moles, TC do sítio
- Atenção a fasciite necrotizante em feridas de evolução rápida e tóxica (emergência)

EVENTRAÇÃO x EVISCERAÇÃO

Característica	Eventração	Evisceração
Pele	Íntegra (fechada)	Aberta/rompida
Vísceras	Contidas sob a pele	EXPOSTAS ao meio externo
Risco	Moderado (hérnia incisional)	Altíssimo (infecção/necrose)
Conduta	Cirurgia eletiva/urgente	URGÊNCIA cirúrgica imediata

EVISCERAÇÃO — EMERGÊNCIA

Rx PROTEGER AS VÍSCERAS E OPERAR

Emergência cirúrgica: jejum, NÃO tentar reintroduzir as vísceras
Decúbito dorsal com joelhos semifletidos (reduz a tensão da parede); ambiente calmo e aquecido
Cobrir as vísceras com COMPRESSAS ESTÉREIS embebidas em SF 0,9% MORNHO, mantendo-as úmidas
NÃO aplicar antisséptico diretamente sobre as vísceras
Comunicar cirurgião imediatamente, acesso venoso, analgesia, monitorização; preparar reabordagem
Fatores de risco/prevenção: controlar infecção, suporte nutricional, evitar esforço/tosse, faixa abdominal quando indicada

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ PON de ____ (cirurgia); complicação: seroma/hematoma/deiscência/ISC/eventração/EVISCERAÇÃO.
- Ferida: secreção ____, pus ____, pele ____ (íntegra/aberta), vísceras expostas ____; sinais sistêmicos/sepsse ____.
- Conduta: drenagem/curativo ____, ATB ____; evisceração -> compressas com SF morno + jejum + acesso.
- Solicito cirurgia (URGENTE se evisceração/ISC profunda/cavitária); UTI se sepsse.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é a diferença essencial entre eventração e evisceração?

- A) Eventração tem vísceras expostas; evisceração não
- B) Na eventração a pele está íntegra (vísceras contidas); na evisceração a pele está aberta com vísceras EXPOSTAS
- C) São sinônimos
- D) Eventração é sempre emergência; evisceração é eletiva
- E) Ambas têm pele aberta

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual a conduta inicial diante de uma evisceração?

- A) Reintroduzir as vísceras manualmente e suturar no leito
- B) Emergência cirúrgica: jejum, cobrir as vísceras com compressas estéreis embebidas em SF 0,9% morno e acionar o cirurgião
- C) Aplicar antisséptico diretamente nas vísceras
- D) Alta com curativo seco
- E) Aguardar 48h observando

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Infecção de sítio cirúrgico SUPERFICIAL sem sinais sistêmicos. Qual a conduta?

- A) Antibiótico endovenoso prolongado para todos
- B) Abrir alguns pontos, drenar coleção e irrigar; ATB apenas se celulite ou sinais sistêmicos
- C) Reabordagem cirúrgica imediata da cavidade
- D) Apenas observação sem abrir a ferida
- E) Iniciar antifúngico

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Seroma volumoso e sintomático em ferida operatória. Qual a conduta?

- A) Reabordagem cirúrgica imediata
- B) Aspiração com agulha para drenagem (podendo repetir)
- C) Antibiótico de amplo espectro
- D) Observação indefinida sem intervenção
- E) Corticoide sistêmico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual fator de risco está associado à deiscência/evisceração de ferida operatória?

- A) Boa nutrição
- B) Infecção da ferida, tosse/vômitos/esforço, obesidade, desnutrição e uso de corticoides
- C) Jejum pré-operatório adequado
- D) Idade jovem
- E) Cirurgia limpa eletiva sem complicações

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na eventração a pele está íntegra (vísceras contidas sob a pele, risco de hérnia incisional); na evisceração a pele está aberta com vísceras expostas — emergência cirúrgica.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A evisceração é emergência: jejum, NÃO reintroduzir as vísceras, cobri-las com compressas estéreis embebidas em SF 0,9% morno (mantendo úmidas) e acionar o cirurgião para reabordagem.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na ISC superficial sem sinais sistêmicos, abre-se alguns pontos, drena-se a coleção e irriga-se; o antibiótico fica reservado a celulite associada ou sinais sistêmicos.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Seroma volumoso/sintomático é tratado com aspiração por agulha (podendo necessitar repetição); seromas pequenos são apenas observados.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Infecção da ferida, tosse/vômitos/esforço, obesidade, desnutrição, corticoides, idade avançada e técnica inadequada predis põem à deiscência e à evisceração.

SM24
Suporte ao Plantão Médico